Epidemiología y etiología del dolor musculoesquelético

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Estado actual del dolor musculoesquelético en nuestro entorno
3. Implicaciones socioeconómicas del dolor musculoesquelético
4. Causas de dolor musculoesquelético
5. Factores de riesgo relacionados con el dolor musculoesquelético
6. Influencia de factores psicológicos en el dolor musculoesquelético
7. Bibliografía

Objetivos

En este tema se tratará la epidemiología y la etiología del dolor musculoesquelético, comentando el estado actual de dicha patología en nuestro entorno, además de las implicaciones socioeconómicas que conlleva, sus causas y los factores de riesgo y factores psicológicos asociados.

Estado actual del dolor musculoesquelético en nuestro entorno

El dolor crónico musculoesquelético afecta alrededor de 100 millones de personas en Europa y a una de cada cuatro en países menos desarrollados.

En España el dolor crónico afecta a aproximadamente el 17-18 % de la población y su intensidad es considerada entre moderada y grave en el 12 % de casos.

El primer gran estudio epidemiológico realizado en Europa sobre dolor crónico fue publicado en 2005. Consistió en una encuesta telefónica realizada a 46 394 personas de 16 países. El 19 % de las personas presentaban dolor crónico moderado o severo. España fue el país que menor prevalencia presentaba de dolor crónico, 12 % (3801 personas) mientras que Noruega fue el país con mayor prevalencia, con el 30 % (2018 personas).

En el estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología (estudio EPISER) se observó que la prevalencia de los pacientes con lumbalgia era la más alta (14,8 %), seguida de gonartrosis (10,2 %), artrosis de manos (6,2 %), osteoporosis (3,4 %) y fibromialgia (2,4 %). De ellos, el 20,6 % refirió haber consumido antiinflamatorios y el 18,2 % analgésicos *(figura 1)*.

El objetivo del estudio EPIDOR (publicado en 2005) fue estimar la prevalencia y la intensidad del dolor en los pacientes con enfermedad del aparato locomotor visitados en consultas externas de reumatología. El diagnóstico principal más frecuente fue el de artrosis (29 %), seguido de artropatía inflamatoria crónica (23,6 %), reumatismos extraarticulares (15,2 %) y fibromialgia (12,7 %). En cuanto a la artrosis, las localizaciones más frecuentes fueron la columna vertebral (14,6 %) y la rodilla (11,9 %). Los fármacos más empleados fueron los AINE (57,5 %), seguidos del paracetamol (29,8 %), el metamizol (6,44 %), los opioides (5,64 %) y otros (4,67 %).

En el estudio PANDHORA, publicado en 2011, se evaluaba el perfil del paciente que acude por primera vez a una unidad de dolor crónico en España. En cuanto al tipo de dolor que presentaban los pacientes, el 96,3 % referían no oncológico predominando el dolor musculoesquelético en el 68 % de los pacientes.

Figura 1.

En la unidad de dolor, los diagnósticos principales de dolor musculoesquelético fueron: lumborradiculalgia (27 %), lumbalgia de origen múltiple (11,6 %), artrosis poliarticular (14 %), monoartrosis (10,5 %), fibromialgia (6,8 %), síndrome miofascial (6,5 %), síndrome postlaminectomía (6,3 %), cervicobraquialgia (6 %), el 10,6 % restante fue diagnosticado de diferentes patologías como tendinitis, bursistis, dolor postraumático, etc.

Según el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicado en diciembre de 2019, el dolor de espalda es el segundo problema de salud crónico (18,5 %) tras la hipertensión arterial. Si se diferencia por género, la artrosis (23,5%) es la afección crónica más frecuente en mujeres seguido de dolor de espalda (lumbar 22,1 % y cervical 20 %).

Implicaciones socioeconómicas del dolor musculoesquelético

El dolor tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, en el ámbito de vida familiar y social, con gran repercusión económica y laboral. La presencia de dolor aumenta cinco veces la probabilidad de uso de los servicios sanitarios, suponiendo una importante carga de costes directos e indirectos *(figura 2)*.

Figura 2.

En el estudio EPIFFAC (realizado para valorar el impacto familiar, socio-laboral y económico de padecer fibromialgia), se objetiva que el 96,6 % de los pacientes atendidos en los centros de salud españoles son mujeres, con una edad media de 52 años. El 84 % de estos pacientes refieren alguna enfermedad concomitante, describiendo solo el 5 % su estado de salud como bueno o muy bueno, siendo las principales áreas afectadas la salud física, el trabajo, el ocio y la salud mental. El 70 % de los pacientes refieren tener muchas o bastantes dificultades para rendir en el trabajo, con un alto porcentaje de absentismo laboral y de baja.

En el estudio publicado en el año 2005, por Martín Mola *et al*., la artrosis (35 %) seguida de la artritis y de los dolores de espalda recurrentes por patologías diferentes a la artrosis/artritis fueron las causas de dolor musculoesquelético crónico más frecuentemente atendidas en las consultas de atención primaria en España.

Sobre la base de informaciones indirectas, internacionalmente se reconoce que el coste aproximado del dolor crónico es de entre el 2,2 % y el 2,8 % del Producto Interno Bruto de los países industrializados. A partir de estas estimaciones se calcula que en España el coste económico varía entre los 13 000 y los 16 000 millones de euros al año, aunque se deben tomar estos datos con cautela, ya que son datos extrapolados y no hay grandes estudios globales que los avalen.

En cuanto a los costes directos que supone el dolor crónico, los pacientes que lo padecen hacen uso del sistema sanitario con más frecuencia que aquellos que no lo padecen. Según datos del estudio *Pain Proposal* los españoles visitaron 6,6 veces a profesionales sanitarios en el último año.

Según el estudio realizado en 2018 por la *Pain Alliance Europe*, hasta el 50 % de las personas que tienen dolor crónico no pueden realizar su trabajo. Más de 2/3 de todas las personas indicaron que sus ingresos habían disminuido debido al impacto de su dolor.

Como conclusión, y según publica la OMS, los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. Entre una de cada tres y una de cada cinco personas, incluidos los niños, sufren una afección osteoarticular o muscular dolorosa y discapacitante que limita la movilidad y la destreza, obligando a jubilaciones anticipadas, reduciendo la riqueza acumulada y afectando a las relaciones sociales.

Causas de dolor musculoesquelético

Las causas que originan dolor musculoesquelético se pueden clasificar en seis grandes grupos: *(tabla 1)*

a. Artrosis

Es una enfermedad inflamatoria articular que produce alteraciones estructurales en el cartílago hialino de la articulación y esclerosis del hueso subcondral, causando dolor, rigidez e impotencia funcional de la articulación afectada. Es más frecuente en la columna cervical y lumbar, los dedos de las manos, la raíz del pulgar, la cadera, las rodillas y el primer dedo de los pies. Tiene origen multifactorial.

b. Artritis reumatoide

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al tejido conectivo. Se caracteriza por la afectación simétrica de múltiples articulaciones y la existencia de diversos síntomas generales inespecíficos y manifestaciones extraarticulares. Se manifiesta típicamente con dolor, tumefacción, rigidez o dificultad de movimiento en diversas articulaciones pequeñas y grandes. Los síntomas generales, que a veces preceden a las manifestaciones articulares y tienden a persistir durante toda la evolución, incluyen cansancio, sensación de malestar, fiebre ligera, inapetencia y pérdida de peso. Las posibles manifestaciones extraarticulares, que suelen presentarse cuando la enfermedad ya está establecida, afectan principalmente a la piel, los vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, los ojos y la sangre *(figura 3)*.

Artropatía degenerativa (artrosis).
Artropatía inflamatoria (artritis, bursitis, tendinitis).
Artropatía por depósitos cristalinos (gota).
Alteración de tejidos blandos (dolor miofascial, fibromialgia).
Enfermedades óseas (osteoporosis).
Enfermedades del tejido conectivo (lupus, esclerodermia, vasculitis).

Tabla 1

Figura 3.

Figura 4.

c. Espondilitis anquilosante

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria, sistémica y crónica, que afecta sobre todo al esqueleto axial y, raramente, las articulaciones periféricas. La mayoría de los pacientes son portadores del antígeno HLA-B27 y pueden presentar agregación familiar. Suele aparecer al final de la adolescencia y se presenta más frecuentemente en el hombre. El tratamiento se dirige a mantener la movilidad de la columna, para evitar la anquilosis, el dolor y la inflamación.

d. Gota

Es una forma de artritis producida por el depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones por niveles elevados de ácido úrico en sangre.

Se puede presentar de forma aguda, manifestándose con una crisis de dolor intenso que afecta normalmente a una articulación, siendo las más habituales la del primer dedo del pie, la del tobillo o la de la rodilla, con inflamación y aumento de la sensibilidad de la zona. La forma crónica se manifiesta en forma de episodios frecuentes de dolor intenso que pueden afectar a varias articulaciones, y suele asociarse a la presencia de nódulos periarticulares llamados tofos *(figura 4)*.

e. Osteoporosis

La osteoporosis se define como una enfermedad generalizada del sistema esquelético caracterizada por la pérdida de masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que compromete la resistencia ósea y que condiciona como consecuencia una mayor fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fracturas.

En las primeras etapas no se producen síntomas, pero, al avanzar la enfermedad, pueden producirse fracturas, aplastamientos vertebrales o cifosis acentuada produciendo dolor.

f. Dolor miofascial y fibromialgia

El síndrome de dolor miofascial es una forma de dolor musculoesquelético caracterizado por dolor local y referido, percibido como profundo y punzante, y por la presencia de puntos desencadenantes miofasciales en cualquier parte del cuerpo, llamados puntos gatillo miofasciales.

La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, crónico, de origen no articular con presencia de dolor a la presión en unos puntos específicos.

Factores de riesgo relacionados con el dolor musculoesquelético

Los factores de riesgo relacionados con el dolor musculoesquelético pueden dividirse en modificables y no modificables.

Factores de riesgo no modificables:

- Tanto la edad avanzada como el género femenino se asocia a mayor probabilidad de desarrollar dolor musculoesquelético.

Factores de riesgo modificables:

- **Obesidad:** estudios epidemiológicos han mostrado que la obesidad es un factor predictor para el desarrollo y progresión de la osteoartritis de rodilla, además se ha relacionado con agravamiento del dolor de espalda y con la artritis reumatoide *(figura 5)*.

Figura 5.

- **Sedentarismo:** el ejercicio físico moderado y adaptado disminuye el dolor y favorece la movilidad.
- **Alcohol:** el consumo de alcohol es un factor de riesgo para la aparición de enfermedades osteoarticulares.
- **Tabaco:** el tabaquismo disminuye la absorción de calcio, aumentando el riesgo de desarrollar osteoporosis. Está asociado a mayor riesgo de fractura de cadera. También se asocia a mayor probabilidad de lesiones traumáticas, lesiones por uso excesivo, a mayor riesgo de padecer artritis reumatoide y dolor lumbar.
- **Laborales:** las situaciones generadas en el ámbito laboral, con malas posturas, sobrecarga de peso, movimientos repetitivos, mal ambiente en el trabajo, etc., también son factores de riesgo extrínsecos *(figura 6)*.

Figura 6.

- Otros factores asociados al dolor que se citan en los estudios realizados son: el bajo estrato socioeconómico, vivir solo, el abuso de sustancias psicoactivas y la ansiedad. La relación de estos factores con el dolor no está clara, pero podría responder a patrones de conducta asociados a su aparición.

Influencia de factores psicológicos en el dolor musculoesquelético

El dolor crónico es una experiencia sensorial y emocional compleja con gran variedad entre las personas según el contexto, el significado del dolor y el estado psicológico de la persona.

El modelo biopsicosocial es un modelo conceptual que propone que se deben incluir factores psicológicos y sociales junto con variables biológicas en la comprensión de la enfermedad médica de una persona, en este caso, el dolor musculoesquelético.

En este modelo, el dolor se considera como un patrón de conducta psicofisiológico interactivo que no puede separarse en distintos componentes independientes psicosociales y físicos.

Los elementos críticos de un enfoque de tratamiento interdisciplinario (basado en este modelo biopsicosocial) son los más efectivos en términos clínicos y los más convenientes en términos económicos para usar en pacientes con dolor crónico. Por tanto, se deben abordar los factores biológicos, psicológicos y sociales de manera simultánea como tratamiento integral del paciente con dolor crónico musculoesquelético *(tabla 2)*.

Los factores cognitivos y emocionales tienen una influencia sorprendentemente importante de la percepción del dolor. Estas relaciones se encuentran en la conectividad de las regiones del cerebro que controlan la percepción del dolor, la atención o la expectativa y los estados emocionales.

En líneas generales, se ha demostrado que aquellas personas con problemas emocionales, de comportamiento, de consumo excesivo de alcohol o con trastornos del sueño, presentan mayores probabilidades de desarrollar dolor musculoesquelético a mediano o largo plazo. En muchos estudios epidemiológicos longitudinales, el dolor crónico y otros síntomas somáticos se pueden predecir por abuso y traumas infantiles, bajo nivel educativo, aislamiento social, depresión y ansiedad.

El catastrofismo, que es un sesgo cognitivo que lleva a imaginar los peores escenarios posibles, predispone a que el dolor se cronifique. Se relaciona con:

- Mayor intensidad del dolor.
- Mayor sensibilidad al dolor.
- Mayor grado de discapacidad percibida.
- **Depresión:** se ha descubierto cierta relación lineal entre síntomas depresivos, discapacidad y dolor, la cual se traduce en una menor calidad de vida. Se ha identificado la depresión como un factor predictor de dolor crónico en muñecas, manos, hombros y columna cervical. La ansiedad en personas con trastornos musculoesqueléticos es una condición bastante común. Se ha observado cierta correlación entre la intensidad del dolor, el grado de discapacidad y la ansiedad. Un estudio observacional demostró que un 50 % de los trabajadores con dolor musculoesquelético asociado a algún grado de discapacidad presentan ansiedad generalizada, que disminuye de manera significativa cuando se realizan intervenciones para mejorar el grado de discapacidad.

El dolor crónico se ha considerado durante mucho tiempo un factor de riesgo para el suicidio *(figura 7)*.

Figura 7.

Los factores de riesgo de mortalidad por suicidio en pacientes con dolor crónico incluyen las características del dolor, la comorbilidad psiquiátrica, otros factores psicológicos, el abuso de sustancias y el fácil acceso a los analgésicos. Aunque el riesgo absoluto de suicidio es muy bajo, es importante evaluar a los pacientes con dolor por abuso de sustancias, comorbilidad psiquiátrica e ideación suicida.

Respecto a los factores sociales relacionados con el trabajo, puede considerarse que la percepción de trabajo pesado, el control excesivo durante la jornada laboral, el desequilibrio entre la vida laboral-familiar asociado a trabajos de altas exigencias físicas son predictores del desarrollo de dolor musculoesquelético. Además, se ha asociado con dolor musculoesquelético el escaso apoyo social en el trabajo, la baja satisfacción laboral, la escasa capacidad de trabajo en equipo y la percepción del trabajo como factor de riesgo.

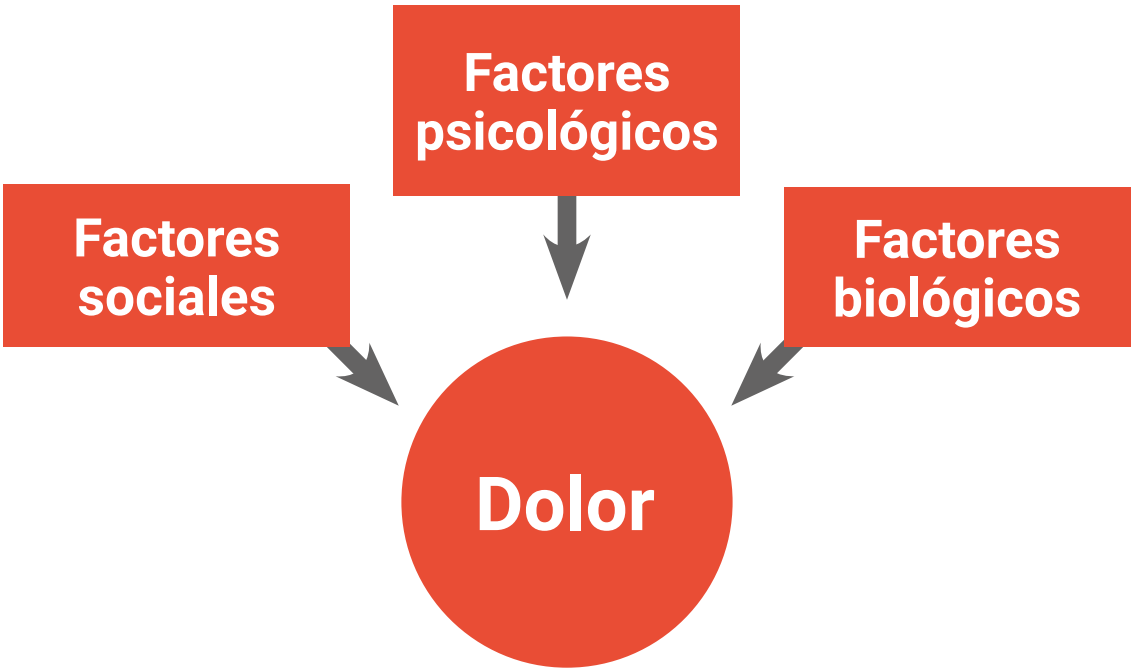

Tabla 2.

Bibliografía

1. Woolf AD, Zeidler H, Haglund U, Carr AJ, Chaussade S, Cucinotta D, et, et al. Musculoskeletal pain in Europe: its impact and a comparison of population and medical perceptions of treatment in eight European countries. Ann Rheum Dis. 2004; 63: 342-7.
2. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006; 10: 287-333.
3. Carmona L, Gabriel R, Ballina J, Laffón A y el grupo de estudio EPISER. Proyecto EPISER 2000: prevalencia de enfermedades reumáticas en la población española. Metodología, resultados del reclutamiento y características de la población. Rev Esp Reumatol. 2001;28(1):18-25.
4. Montero Matamala, A., Samper Bernal, D., Vidal Fuentes, J., Rodríguez Dinten, M. J., & Jiménez Cosmes, L. Estudio para evaluar el perfil del paciente que acude en primera visita a Unidades de Dolor de centros hospitalarios españoles: (estudio PANDHORA). Revista de la Sociedad Española del Dolor. 2011; 18(4): 219-227.
5. Gamero Ruiz F, Gabriel Sánchez R, Carbonell Abello J, Tornero Molina J, Sánchez-Magro I. El dolor en las consultas de Reumatología españolas: estudio epidemiológico EPIDOR. Rev Clin Esp. 2005;205(4):157-63.
6. Collado et al. Work, family and social environment in patients with Fibromyalgia in Spain: an epidemiological study: EPIFFAC studyBMC Health Services Research 2014, 14:513.
7. E. Martín Mola, AD. Woolf, H. Zeidler, U. Haglund, AJ. Carr. Evaluación del dolor musculoesquelético crónico en la población adulta española y su manejo en Atención Primaria: actitudes, percepción del estado de salud y uso de recursos sanitarios. SEMERGEN. 2005;31(11):508-15.
8. González-Escalada JR. Actualizaciones en los aspectos socioeconómicos del dolor. En: Muriel C. Actualizaciones en el control del dolor: diez años. Reunión de expertos. Salamanca: Fundación Grünenthal. 2010: 145-69.
9. InSites Consulting. Pain Proposal Patient Survey. 2010; July-September.
10. Survey On Chronic Pain And Your Work Life: A Survey

In 14 EU Countries. PAIN ALLIANCE EUROPE. 2018.

11. Situación de Salud. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2018. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
12. Hermoso de Mendoza M.T. Clasificación de la osteoporosis: Factores de riesgo. Clínica y diagnóstico diferencial. Anales Sis San Navarra. 2003; 26(3): 29-52.
13. Greenspan JD, Craft RM, LeResche L, Arendt-Nielsen L, Berkley KJ, Fillingim RB, et al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: a consensus report. Pain. 2007;132(1):S26-S45.
14. Nestares T, Salinas M, De Teresa C, Díaz-Castro J, Moreno-Fernández J, López-Frías M. Factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida en pacientes con patología osteomuscular. Nutr Hosp. 2017;34: 444-453.
15. Cuyul Vásquez I y Araya-Quintanilla F. Influencia de los factores psicosociales en la experiencia de dolor musculoesquelético: una revisión de la literatura. Rev Soc Esp Dolor. 2019;26(1):44-51.
16. Coutu M-F, Durand M-J, Marchand A, Labrecque M-E, Berbi- che D, Cadieux G. Factors associated with generalized anxie- ty in workers undergoing work rehabilitation for persistent musculoskeletal pain. Disabil Rehabil. 2013;35(19):1599- 607.
17. Hassett AL, Aquino JK, Ilgen MA. The risk of suicide mortality in chronic pain patients. Current pain and headache reports. 2014;18:436.
18. Cuyul Vásquez I y Araya-Quintanilla F. Infl uencia de los factores psicosociales en la experiencia de dolor musculoesquelético: una revisión de la literatura. Rev Soc Esp Dolor. 2019;26(1):44-51.